



El Barómetro Sanitario 2026 revela una espera media de 90,1 días en salud mental, el Colegio de Psicología de Madrid mantiene su dispositivo de emergencia por los incendios y la OCDE alerta del deterioro sostenido del bienestar juvenil: claves del 14 de agosto de 2026

VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Barómetro Sanitario 2026 del Ministerio de Sanidad revela que el 18,2 % de la población española necesitó atención por un problema de salud mental en el último año, con una espera media de 90,1 días hasta la primera consulta especializada. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid mantiene activo un dispositivo de primeros auxilios psicológicos para las personas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. La OCDE alerta de un deterioro sostenido del bienestar psicológico infantojuvenil en la última década en la mayoría de sus países miembros. Un estudio publicado en Nature Mental Health con más de 23.000 participantes actualiza los correlatos cerebrales de la depresión, y otro en Psychiatric Services documenta el aumento de los internamientos psiquiátricos involuntarios en Ontario.

Noticias nacionales

El Barómetro Sanitario 2026 revela una espera media de 90,1 días para la primera consulta de salud mental

Según informa Infocop, la primera oleada del Barómetro Sanitario 2026, la encuesta anual que el Ministerio de Sanidad realiza en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 1993, revela que el 18,2 % de la población española ha necesitado consultar a un profesional sanitario en el último año por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional. La primera oleada se realizó entre finales de marzo y comienzos de abril de 2026 con 2.602 entrevistas, de las aproximadamente 7.800 previstas para el conjunto del año, por lo que sus resultados deben interpretarse como provisionales. Entre quienes buscaron atención, el 59,6 % fue atendido a través de la sanidad pública, el 6,6 % mediante un seguro médico privado y el 23,8 % recurrió directamente a un profesional privado mediante pago directo. Dentro del sistema público, la atención se repartió entre médicos y médicas de familia (43,1 %), psiquiatría (31 %) y psicología (16,9 %), y el 52,5 % de las personas atendidas valoró positivamente la asistencia recibida. El barómetro documenta también los tiempos de espera: entre las personas derivadas desde atención primaria a un especialista de la sanidad pública, la espera media hasta la primera consulta fue de 90,1 días, y de 147,7 días entre consultas de seguimiento. Además, el 48,8 % de la población declara que le resulta difícil encontrar información sobre salud mental, uno de los ámbitos peor valorados del apartado de alfabetización sanitaria incluido por primera vez en la encuesta.

Fuente: Infocop (Barómetro Sanitario 2026, Ministerio de Sanidad y CIS)

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid activa un dispositivo de emergencia para las personas afectadas por los incendios

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en colaboración con la Comunidad de Madrid a través del Summa y de las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano, activó dispositivos de atención psicológica en crisis, de carácter presencial e itinerante, para las personas desplazadas y afectadas por los

incendios que han afectado a distintos municipios de la Sierra Oeste de Madrid. Según informó el Colegio Oficial, los dispositivos están integrados por más de 40 profesionales de la psicología especializados, que atienden en albergues temporales, centros de acogida, puntos de reunión y otros espacios habilitados para la población afectada. La intervención tiene como finalidad proporcionar primeros auxilios psicológicos, tanto a nivel individual como familiar, con el objetivo declarado de reducir el impacto emocional inicial, favorecer la estabilización psicológica, detectar a las personas especialmente vulnerables, identificar necesidades prioritarias y facilitar la conexión con los recursos de apoyo disponibles. El Colegio ya había puesto a disposición de la Administración sus recursos profesionales el 24 de julio, ante las dificultades a las que se enfrentaban los equipos de emergencia en las labores de extinción. La institución trasladó su reconocimiento a los y las profesionales que intervienen en la emergencia y expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas.

Fuente: Servimedia

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OCDE alerta de un deterioro sostenido del bienestar psicológico juvenil en la última década

Según informa Infocop, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala en su informe Child, Adolescent and Youth Mental Health in the 21st Century, publicado en 2026, que la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ha deteriorado de forma sostenida durante la última década en la mayoría de los países de la organización. El documento se basa en datos nacionales e internacionales, revisión de la literatura científica y entrevistas semiestructuradas realizadas en 2025 a 29 expertos clínicos y responsables de políticas públicas en salud mental juvenil. Según el informe, los problemas psicológicos afectan aproximadamente a uno de cada cinco jóvenes en los países de la OCDE, y el 62,5 % de los trastornos mentales tendría su inicio antes de los 25 años. De los once países con datos comparables, nueve

registraron entre 2012 y 2022 un deterioro medio anual de los indicadores de salud mental juvenil de entre el 3 % y el 16 %; solo Japón y Corea mostraron pequeñas mejoras. El informe señala diferencias por sexo y edad: en 2022, el 68 % de las chicas de 15 años declaró presentar múltiples quejas de salud, frente al 36 % de los chicos de la misma edad, y la proporción de chicas que afirmaban sentirse bajas de ánimo más de una vez por semana aumentó del 28,6 % en 2014 al 45,4 % en 2022. Entre los 13 países con datos disponibles, las hospitalizaciones por autolesiones en chicas de 0 a 17 años aumentaron un 29 % entre 2015 y 2023, mientras que las tasas de suicidio juvenil se mantuvieron relativamente estables. La OCDE recomienda reforzar la prevención y los apoyos tempranos en los ámbitos educativo, sanitario, familiar y digital.

Fuente: Infocop (informe de la OCDE)

Publicaciones científicas recientes

Hamilton, K. M., et al. (2026). The neuroimaging correlates of depression established across six large-scale population datasets. *Nature Mental Health*.

DOI: [10.1038/s44220-026-00680-y](https://doi.org/10.1038/s44220-026-00680-y)

Hallazgo: El estudio, publicado en *Nature Mental Health*, analizó 23.417 participantes procedentes de seis grandes bases de datos poblacionales de neuroimagen (ABCD, UK Biobank, Human Connectome Project en sus versiones de adultos jóvenes, desarrollo y envejecimiento, y el estudio ANXPE), con el objetivo de establecer de forma sistemática los correlatos estructurales y funcionales de la depresión. Mediante modelos de regresión de efectos mixtos aplicados por separado a cada base de datos y posteriormente combinados en un metaanálisis con corrección por tasa de falso descubrimiento, los autores hallaron reducciones de volumen de sustancia gris y de superficie cortical asociadas a la depresión en la corteza frontal, el cíngulo anterior y la ínsula, confirmando hallazgos previos sobre la relevancia de las regiones prefrontales y de la red neuronal por defecto. De forma inesperada, no se encontraron correlatos estructurales significativos en regiones subcorticales, mientras que sí aparecieron asociaciones significativas en regiones somatomotoras y visuales (paracentral, poscentral, precentral, fusiforme y pericalcarina), tradicionalmente poco relacionadas con la depresión. Los

tamaños del efecto fueron mayores para las medidas de gravedad sintomática autoinformada que para las medidas de rasgo de personalidad (neuroticismo) utilizadas como indicador de vulnerabilidad.

Implicación clínica: Los autores señalan que estos resultados actualizan de forma sustancial la comprensión de los correlatos neurológicos de la depresión y sugieren que la investigación futura podría beneficiarse de prestar más atención a las regiones somatomotoras y visuales. Los propios autores advierten de limitaciones importantes: la mayoría de las personas participantes no fueron diagnosticadas mediante herramientas clínicas estandarizadas, sino a través de medidas autoinformadas, por lo que los hallazgos podrían no ser directamente extrapolables a muestras con diagnóstico clínico confirmado.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Historia clínica electrónica interoperable:** Según los datos del Barómetro Sanitario 2026, el 39,5 % de la población ha accedido alguna vez a su historia clínica electrónica de la sanidad pública, el 63,1 % sabe que puede retirar medicación prescrita fuera de su comunidad autónoma mediante la receta electrónica interoperable, y el 41,9 % conoce que los y las profesionales sanitarios pueden consultar electrónicamente informes clínicos generados en otras comunidades autónomas cuando es necesario atender a un paciente. Se trata de infraestructuras digitales de uso público, gestionadas por las administraciones sanitarias, orientadas a mejorar la continuidad asistencial entre niveles y territorios.

Prioridades del día

Gestión de los tiempos de espera en salud mental

A la luz de los datos del Barómetro Sanitario 2026 sobre los tiempos de espera en salud mental, puede ser útil revisar los circuitos propios de derivación y seguimiento, y valorar cómo la consulta privada puede

coordinarse con la atención recibida en la sanidad pública durante la espera media registrada.

Protocolos de primeros auxilios psicológicos ante emergencias

Ante dispositivos como el activado por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid frente a los incendios, puede ser relevante mantener actualizado un protocolo propio de primeros auxilios psicológicos en catástrofes y revisar la formación específica disponible para quienes trabajan con población en situación de riesgo.

Prevención en la atención a la salud mental infantojuvenil

Considerando las alertas de la OCDE sobre el deterioro sostenido del bienestar psicológico en la infancia y la adolescencia, puede ser oportuno incorporar cribados breves de bienestar emocional en la consulta con población infantojuvenil y reforzar la coordinación con el ámbito escolar y familiar.